

# Control de proveedores laboratorios y servicios externos

## Objetivo

Establecer una secuencia verificable para control de proveedores laboratorios y servicios externos, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

## Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontología ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

## Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

## Seleccionar

Verificar identidad, permisos/habilitación cuando aplican, competencia, productos, tiempos y manejo de datos. El laboratorio de prótesis necesita protocolo de desinfección y trazabilidad; reprocesamiento requiere controles y alcance pactados.

## Evaluar

Registrar orden, recepción, conformidad, reclamo y corrección. Revisar material, resultado, integridad y oportunidad; no incorporar en atención elemento no conforme por presión de agenda.

## Cerrar

Mantener contrato/soportes reales y proveedor alternativo. Auditar según riesgo y no fabricar licencia o certificación para llenar expediente.

## **Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones**

### **Aplicabilidad y responsables**

Relacionar este documento con sede, servicio, modalidad y tareas realmente realizadas. Designar ejecutor, suplente y revisor por nombre/rol; comprobar competencia y recursos. Si No aplica, justificar con oferta real y criterio normativo, sin utilizarlo para ocultar una actividad que sí se ejecuta.

### **Preparación del proceso**

Reunir información y soportes descritos en sus secciones: documentos vigentes, equipos o productos identificados, condiciones de sede y proveedores verificados. Revisar fechas, integridad y coherencia entre el soporte y la operación; una certificación de otro equipo o profesional no es intercambiable.

### **Ejecución y evidencia**

Registrar actividades reales con fecha, responsable, resultado y ubicación del soporte. Diferenciar programación de ejecución y solicitud de respuesta recibida. Mantener versión de origen, trazabilidad de cambios y acceso apropiado; no completar registros retrospectivamente sin señalar adenda.

### **Hallazgos y cierre**

Describir incumplimiento, riesgo y medida inmediata. Asignar corrección, responsable y plazo; mantener estado Pendiente mientras no exista soporte verificable. La reapertura o aprobación exige revisión del resultado, no solo afirmación de cumplimiento.

### **Seguimiento del estándar**

Revisar muestra de registros y observar práctica/recursos. Comparar requisito, evidencia documental y condición real; analizar repetición de fallas y actualizar controles. Conservar acuerdos y permisos auténticos cuando el proceso depende de terceros.

### **Frecuencia y puntos de control**

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

### **Registros relacionados**

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-INT03 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

## Verificación, fundamento y adopción

### Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas  $\times 100$ . Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

### Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

### Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

<https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609>

### Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

### Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.

Aprobó  
**danko jimenez**